

Universidade Federal de Santa Catarina
Departamento de Biologia Celular, Embriologia E Genética
PPG Biologia Celular e do Desenvolvimento
Laboratório de Polimorfismos Genéticos (LAPOGE)

Pós-doutorando: Dr. Tiago Fernando Chaves

Supervisores: Profa Dra Yara Costa Netto Muniz & Daniel

Pacheco Bruschi



Case 04

Prontuário Clínico: Link

Identificação do Paciente

- **Nome:** Link
- **Data de Nascimento:** 20/07/2023
- **Idade:** 2 anos e 4 meses
- **Sexo:** Masculino
- **Cor:** Caucasiano
- **Registro:** HYRULE-NEURO-2025-001
- **Data da Anamnese:** 12/11/2025

História Clínica (HDA) - Queixa Principal e História de Doença Atual

Paciente encaminhado por neuropediatria devido a **atraso global do desenvolvimento neuropsicomotor** e **problemas respiratórios** observados desde o período neonatal.

Neonatal/Infância Precoce: No período neonatal, Link apresentou **episódios recorrentes de respiração rápida e superficial (taquipneia)**, que se alternavam com **períodos de apneia**, exigindo monitoramento hospitalar prolongado.

Desenvolvimento Motor: Apresenta **hipotonia axial grave** (corpo mole) persistente. O paciente **não adquiriu a marcha independente** e senta com dificuldade e instabilidade. Há um **desequilíbrio motor acentuado** e movimentos oculares anormais.

Oftalmológico: Observação de movimentos oculares atípicos (nistagmo) e suspeita de baixa visão, que tem dificultado a interação com o ambiente.

Sistêmico: Acompanhamento ambulatorial mostra **discreta elevação dos níveis de creatinina** e poliúria (aumento do volume de urina) nos últimos meses.

História Familiar (HF)

- **Pai (Nome Omitido):** 35 anos, saudável.
- **Mãe (Nome Omitido):** 33 anos, saudável. Nega consanguinidade.
- **Irmão (Nome Omitido):** 8 anos, desenvolvimento típico e saudável.
- **Histórico Secundário:** A família relata um primo de segundo grau que, na infância, teve **problemas graves de coordenação motora e que necessitou de diálise** na adolescência.

Exame Físico

- **Estado Geral:** Desperto, mas visivelmente hipotônico.
- **Dismorfias Faciais:** Sem dismorfias maiores. Pálpebras caídas (Ptose) e a mãe relata **"olhar flutuante"** (nistagmo).

- **Neurológico:**
 - **Hipotonia Axial Acentuada.**
 - **Ataxia:** Presença de dismetria e dificuldade em manter a postura sentada (falha na coordenação de movimentos).
 - **Reflexos:** Normais.
 - **Geral:** Sem polidactilia ou outras anomalias de extremidades.
 - **Cardiopulmonar:** Padrão respiratório por vezes irregular e alternante (taquipneia/apneia).
-

Exames Complementares (Achados Chave)

- **Ressonância Magnética (RM) do Crânio (Realizada aos 6 meses):**
 - **Hipoplasia do Vermis Cerebelar** (desenvolvimento incompleto da porção central do cerebelo).
 - **Aprofundamento da Fossa Interpeduncular e Alargamento da Cisterna Interpeduncular.**
 - **Achado Clássico:** Ausência de cruzamento dos feixes de fibras nervosas no tronco encefálico (sinal do "dente molar" no corte axial, indicativo de anomalia do tronco encefálico).
 - **Ultrassonografia Renal (Recente):**
 - Rins de dimensões normais a aumentadas. Presença de **cistos corticais e medulares bilaterais de pequeno e médio porte** (Doença Renal Cística).
 - **Função Renal (Laboratório):**
 - Creatinina sérica ligeiramente elevada para a idade.
-

Impressão Clínica (Envolvimento Cerebelar, Respiratório e Renal)

Paciente jovem apresentando uma **triade complexa de disfunção do sistema nervoso central, distúrbio respiratório e nefropatia cística**, sugerindo fortemente uma patologia genética com comprometimento pleiotrópico (múltiplos órgãos).

Achados Chave Associados:

1. **Anomalia Estrutural do Tronco Encefálico/Cerebelo** (RM do crânio).
2. **Disfunção Neurológica:** Hipotonia, Ataxia e Atraso no Desenvolvimento Motor.
3. **Disfunção Respiratória:** Padrão de respiração irregular (central).
4. **Nefropatia:** Doença Renal Cística e Insuficiência Renal incipiente.

Nota: A combinação destes achados, especialmente a malformação do tronco encefálico/cerebelo com doença cística renal, é altamente sugestiva de um defeito genético único que afeta a função e desenvolvimento de cílios primários.

Plano de Conduta

1. **Investigação Etiológica:** Coleta de amostras para **Painel de Sequenciamento Genético** focado em doenças neurológicas com anomalias de tronco encefálico e nefropatias císticas (e.g., genes **AHI1**, **CEP290**, **NPHP1**, **TMEM67**).
2. **Multidisciplinaridade:** Iniciar acompanhamento com:
 - **Geneticista:** Para diagnóstico e aconselhamento familiar.
 - **Nefrologista:** Para manejo e monitoramento da doença renal cística.
 - **Fisioterapeuta/Terapeuta Ocupacional:** Para manejo da hipotonia e ataxia.
3. **Monitoramento:** Monitoramento contínuo da função respiratória, especialmente durante o sono.